病　程　记　录

姓名：于文才　　性别：男　　年龄：69岁　　科室：内科综合　　床位：13-30　　住院号：201909421

首次病程记录

2019年11月18日16时28分

患者于文才，男性，69岁，因“右侧肢体麻木5天，伴肢体无力2天”于2019年11月18日14时55分扶入病室。

病例特点：

1.患者男性，69岁；既往高血压病病史10年，血压最高可达：160/110mmHg，现规律口服替米沙坦片，未监测血压；脑梗塞病史9年，遗留言语含糊不清，饮水时有呛咳，行走缓慢，规律口服阿司匹林肠溶片、他汀类药物控制病情。

2.患者于5天前，无明显诱因出现右侧肢体麻木不适感，麻木呈持续性，无头晕、头痛，无肢体活动不灵，活动后麻木无减轻，因症状较轻，未给予重视，入院前2天，晨起时自觉麻木较前加重，且伴明显头晕、头沉不适，频繁呛咳，右侧肢体无力感，右手持物不稳，穿衣时右侧肢体活动欠灵，走路右腿拖地且步态不稳，右侧肢体有明显发凉感，无意识不清，无抽搐发作，无视物旋转，无恶心呕吐，充分休息后上症未见好转。今日为求系统治疗前来我就诊，门诊检查后以“腔隙性脑梗塞”收入院。平素饮食、睡眠尚可，二便正常。

3.查体：体温：36.5℃ 脉搏：70次/分 呼吸：20次/分 血压：130/90mmHg，发育正常，营养中等，神清语明，查体合作；全身皮肤粘膜无黄染及出血点，全身浅表淋巴结无肿大，结膜无充血，巩膜无黄染，扁桃体无红肿，咽峡无充血；双肺听诊呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率：70次/分，心律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音；腹软，无压痛，肝脾肋下未触及；双下肢无水肿。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退，计算力、定向力正常，查体合作；双侧额纹对称，双侧瞳孔等大同圆，对光反射灵敏，双眼位居中，眼球运动充分，无眼震，双侧鼻唇沟无变浅，伸舌居中，悬雍垂居中，软腭上抬充分；右上肢肌力4+级、肌张力正常，右下肢肌力4+级、肌张力正常，左侧肢体肌力、肌张力正常；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退，双侧深感对称存在；右侧Babinski征、Chaddock征阴性，颈强（-）、克氏征阴性。

4.辅助检查：头颅CT（2019-11-20 本院 CT号：17294）：双侧基底节、放射冠区见点状低密度影，边缘模糊，大小不超过1.0cm，脑沟增宽，第三脑室以上脑室系统扩张，脑干似见点状低密度影，影像诊断：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

初步诊断：腔隙性脑梗塞
脑梗塞后遗症期
高血压病

诊断依据：

1.患者男性，69岁；5天前出现右侧肢体麻木不适感，麻木呈持续性，入院前2天，晨起时自觉麻木较前加重，且伴明显头晕、头沉不适，频繁呛咳，右侧肢体无力感，右手持物不稳，穿衣时右侧肢体活动欠灵，走路右腿拖地且步态不稳，右侧肢体有明显发凉感。

2.神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。

3.辅助检查：头颅CT：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

4.高血压病病史10年；脑梗塞病史9年。

鉴别诊断：

1.脑出血:由于出血量小，血肿局限，起病可为渐进性，临床表现可与腔隙性脑梗塞相似，须依靠CT或MRI鉴别，但是脑出血有其特点，即脑出血一般在体力和脑力紧张活动或情绪激动时容易发病，起病急，发展快，数十分钟到数小时达到高峰，急性发病者典型的表现有：头痛，呕吐，失语，肢体运动障碍，抽搐，不同程度的意识障碍，脑出血的临床表现与出血部位和出血量有很大关系，脑CT扫描可以发现出血病灶，有利于鉴别诊断。

2.脑梗死:指腔隙直径大于20mm，可能有多个穿通动脉闭塞，或较大的动脉粥样硬化或血栓形

病　程　记　录

姓名：于文才　性别：男　年龄：69岁　科室：内科综合　床位：13-30　住院号：201909421

成所引起，神经系统定位体征较明显或症状较重，可伴有意识障碍，预后较差。

诊疗计划：

1.内科入院常规、二级护理、低盐低脂饮食、测血压 日二次。

2.给予改善循环、改善脑代谢治疗：0.9%氯化钠注射液250ml+曲克芦丁脑蛋白水解物注射液10ml 日一次静点；0.9%氯化钠注射液100ml+前列地尔10ug 日一次静点。

3.抗血小板聚集、抗动脉硬化、降压药物治疗：阿司匹林肠溶片100mg 日一次口服；阿托伐他汀钙片20mg 日一次口服；替米沙坦片40mg 日一次口服。

4.给予肢体功能治疗：脑血管病针灸 每日一次。

5.完善相关实验室检查。

医生签字：　王科英/　樊庆欢

病　程　记　录

姓名：于文才　　性别：男　　年龄：69岁　　科室：内科综合　　床位：13-30　　住院号：201909421

2019年11月19日10时01分　　王雪峰主治医师查房记录

汇报病史：患者男性，69岁；5天前出现右侧肢体麻木不适感，麻木呈持续性，入院前2天，晨起时自觉麻木较前加重，且伴明显头晕、头沉不适，频繁呛咳，右侧肢体无力感，右手持物不稳，穿衣时右侧肢体活动欠灵，走路右腿拖地且步态不稳，右侧肢体有明显发凉感。**查体：**体温：36.3℃ 脉搏：70次/分 呼吸：19次/分 血压：133/80mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。辅助检查：头颅CT：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

临床确定诊断：腔隙性脑梗塞
脑梗塞后遗症期
高血压病

诊断依据：

1.患者男性，69岁；右侧肢体麻木5天，伴肢体无力2天。

2.神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。

3.辅助检查：头颅CT：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

4.高血压病病史10年；脑梗塞病史9年。

病情分析：患者现主要表现右侧肢体麻木5天，伴肢体无力2天，CT见梗塞灶出现，梗塞灶都在1CM左右，符合腔隙性脑梗塞诊断，治疗上应积极给予抗血小板聚集、调脂、改善循环及恢复肌力等治疗，还应控制好血压、血糖。

处置：继续目前治疗。

医生签字：　　王雪峰/　　樊庆欢

2019年11月19日13时26分

实验室检查回报：血常规、肝功能、肾功能、血脂四项、血糖、乙肝表面抗原、凝血四项、同型半胱氨酸均正常。血流变提示血粘度增高。尿常规：尿蛋白（+-）尿胆原（+）尿胆红素（+）。

患者血粘度增高，继续改善循环药物治疗，并嘱患者增加饮水量。

患者尿蛋白弱阳性，尿胆原阳性、尿胆红素阳性，但肝功能无异常，暂不考虑肝胆疾病，嘱患者多饮水后复查。

医生签字：　　王科英/　　樊庆欢

2019年11月20日10时30分　　姜淑文副主任医师查房记录

汇报病史同上。今日患者肢体活动欠灵减轻。**查体：**体温：36.3℃ 脉搏：80次/分 呼吸：18次/分 血压：140/88mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。

临床确定诊断：腔隙性脑梗塞
脑梗塞后遗症期
高血压病

分析与处置：患者现诊断明确，因此入院给予抗凝、抗动脉硬化治疗为主，辅以改善症状症状物理治疗，注意低脂饮食、监测血压。

医生签字：　　姜淑文/　　樊庆欢

2019年11月21日15时01分

辅助检查回报：超声提示：双侧颈动脉斑块 双侧颈动脉硬化。结合超声回报，患者已有颈动脉硬化及颈动脉硬化斑块形成，继续抗动脉硬化治疗。

医生签字：　　王科英/　　樊庆欢

2019年11月22日08时26分

病　程　记　录

姓名：于文才　　性别：男　　年龄：69岁　　科室：内科综合　　床位：13-30　　住院号：201909421

患者头晕明显减轻，右侧肢体麻木及无力有所减轻。**查体：**血压：135/80mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。处置：巩固治疗。

医生签字：　　王科英/　　樊庆欢

2019年11月24日09时32分　　王雪峰主治医师查房记录

患者无明显头晕，站立平稳，能短距离行走。**查体：**血压：132/81mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利；右上肢肌力4+级，右下肢肌力5-级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。继续目前治疗。

医生签字：　　王雪峰/　　樊庆欢

2019年11月26日10时40分　　姜淑文副主任医师查房记录

患者病情平稳，无明显头晕，站立平稳，能短距离行走。**查体：**血压：136/78mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利；右上肢肌力4+级，右下肢肌力5-级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠准、稳；右侧温度觉减退。继续目前治疗方案。

医生签字：　　姜淑文/　　樊庆欢

2019年11月28日11时01分

患者右手持物较前平稳。**查体：**血压：133/80mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利；右上肢肌力5-级，右下肢肌力5-级；右侧指鼻试验稳、欠准，右侧跟膝胫试验欠准、稳；右侧温度觉减退。处置：巩固治疗。

医生签字：　　王科英/　　樊庆欢

2019年11月30日08时46分

患者常觉髋腰部酸痛，时有乏力不适。为排除骨质疏松，予以行骨密度检查。骨密度回报骨量减少。嘱患者适当补充钙剂，增加高钙食物的摄入。

医生签字：　　王科英/　　樊庆欢

2019年11月30日17时00分

患者诉上午不慎滑倒，右侧肋骨下缘疼痛，无红肿，挤压征（+），行胸部DR检查。

医生签字：　　刘亚平

2019年12月01日12时04分　　王雪峰主治医师查房记录

胸部DR示（2019-12-01 本院 DR号：17395）：主动脉粥样硬化 双肺纹理增强 心肺隔无著变。结合DR回报，未见骨折迹象，考虑患者有软组织损伤，现疼痛不影响诊断正常生活，无需处置。

医生签字：　　王雪峰/　　樊庆欢

2019年12月04日08时00分　　姜淑文副主任医师查房记录

患者病情平稳，无头晕不适，右手持物较前平稳，站立平稳，能短距离行走，步态较前平稳，右侧肢体麻木及无力减轻。**查体：**血压：135/78mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利；右上肢肌力5-级，右下肢肌力5-级；右侧指鼻试验稳、欠准，右侧跟膝胫试验欠准、稳；右侧温度觉减退。今日予以办理出院，立普妥2盒、替米沙坦片1盒离院带药。阿司匹林肠溶片100mg 日一次口服；阿托伐他汀钙片20mg 日一次口服；替米沙坦片40mg 日一次口服。低盐低脂饮食，监测血压，适量运动，病情变化随诊。

医生签字：　　姜淑文/　　樊庆欢